RSUD dr. LOEKMONO HADI Sehat Anda, Senyum Kita **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI** Jl dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus	**DO NOT RESUSITATION (DNR)**		
	No.Dokumen 400.7.3.4/825/2026	No.Revisi 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 15 Juni 2026	Ditetapkan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Wakil Direktur Pelayanan dr. MUSTIKO WIBOWO, M.K.M Pembina Tk. I NIP. 19820915 200903 1 004	

PENGERTIAN	Resusitasi : intervensi medis yang bertujuan untuk memulihkan untuk memulihkan aktifitas jantung atau pernafasan, dan yang tercantum disini : 1. Pacu jantung (penekanan dada) 2. Defibrilasi 3. Asisted ventilasi 4. Endotrakeal intubasi 5. Pemberian obat kardiotonik DNR : Permintaan untuk tidak melakukan resusitasi. Merupakan persetujuan untuk perawat dan dokter agar tidak melakukan atau memberikan tindakan pertolongan berupa CPR jika terjadi masalah darurat pada henti jantung atau henti nafas dari pasien. Sebuah pernyataan DNR ditanggapi jika : 1. Terdapat bukti legal baik fotokopi maupun asli yang berisi permintaan pasien untuk tidak melakukan resusitasi/DNR. 2. Pasien memakai gelang DNR 3. Untuk pasien yang berada dalam proses transfer ke fasilitas kesahatan lainnya, dokumen yang ditulis dalam dalam catatan permanen medis pasien yang berisi peryataan “Jangan Resusitasi”, “Kode Tidak Resusitasi”, “Do Not Resusitate (DNR)”atau “Tidak CPR”, telah dilihat oleh personil tenaga medis Rumah Sakit Daerah dr.

	Loekmono Hadi. Keaslian dokumen ini harus didokumentasikan oelh saksi dari fasilitas perawatan kesehatan.
TUJUAN	Sesuai acuan penerapan langkah langkah untuk menerapkan kriteria ketika menentukan tidak dilakukan tindakan resusitasi/DNR yang memenuhi persyaratan perundang-undangan dan hak-hak pasien.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi No. 3 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus
PROSEDUR	A. DNR pasien masih hidup 1. Dokter wajib menjelaskan resiko yang mungkin dialami pasien ketika sewaktu dalam masa perawatan terjadi henti jantung, henti nafas dengan pertimbangan kondisi pasien : 1) Prognosis buruk 2) Lanjut usia 3) Gagal multi organ 4) Keganasan stadium akhir 5) Fungsi cerebral yang tidak mungkin pulih 2. Dokter atau perawat tidak boleh melakukan resusitasi pada pasien yang mempunyai permintaan DNR, kecuali permintaan tersebut belum dibuktikan dengan keterangan yang jelas dan legal. 3. Meminta pertimbangan pasien/keluarga pasien untuk melakukan resusitasi ataupun menolak dilakukan resusitasi (DNR), jika dalam keadaan darurat dimana pasien membutuhkan tindakan pertolongan CPR. Jika pasien atau keluarga pasien meminta untuk menolak dilakukan tindakan resusitasi (DNR), maka permintaan pasien atau

keluarga harus dihormati.

4. Dokter mengisi lengkap rekam medis pasien dan juga memberikan form inform consent penolakan tindakan resusitasi kepada pasien dan keluarganya yang harus ditanda tangani oleh dokter, pasien (bila sadar) dan saksi-saksi.
5. Petugas memberikan gelang DNR sebagai penanda bahwa pasien tersebut memiliki permintaan untuk tidak dilakukan resusitasi.
6. Sebuah permintaan penolakan resusitasi (DNR) dianggap batal/ tidak berlaku, jika dari keadaan ini terjadi :
   1) Pasien sadar dan menyatakan bahwa ia ingin di resusitasi
   2) Ada keberatan atau perselisihan dengan anggota keluarga atau pengasuh
   3) Ada pernyataan perselisihan mengenai order DNR

B. DNR pada pasca resusitasi prognosis buruk

1. Selama proses tindakan resusitasi, petugas medis disajikan dengan order DNR sebagaimana ditentukan sebelumnya.
2. Tanda jelas mati (triple zero). Jelas pasien meninggal adalah mereka ditemukan non-benafas, pulseless, asystolic, dan memiliki satu atau lebih dari jangka panjang indikasi berikut kematian :
   1) Dekapitasi
   2) Rigor mortis tanpa hypothermia
   3) Profound dependent lividity
   4) Decomposition (pembusukan)
   5) Mummifikasi ? putrifikasi
   6) Insenerasi
   7) Pembekuan mayat

3. Identifikasi yang benar dari pasien sangat penting dalam proses ini. Jika tidak mengenakan tanda DNR, pasien harus positif diidentifikasi sebagai orang yang disebutkan dalam orde DNR. Hal ini biasanya akan memerlukan baik kehadiran saksi keluarga pasien.

C. Pasien DNR yang dalam kondisi sedang dioperasi

Ketika oeder DNR adalah operasi, jika pasien tidak teraba nadi dan apneu, resusitasi akan ditahan atau dihentikan. Pasien menerima perawatan lengkap selain resusitasi (misalnya, untuk obstruksi jalan nafas, nyeri, dyspnea, perdarahan, dll)

D. DNR pasien dalam Transportasi/Rujuk

Order DNR harus dihormati selama transportasi rujukan. Dalam hal pasien berakhir selama transportasi, berikut harus dipertimbangkan :

1. Kecuali secara khusus meminta pasien tidak harus dikembalikan ke kediaman pribadi atau fasilitas keperawatan terampil.
2. Lanjutkan ke rumah sakit tujuan atau kembali ke rumah sakit yang berasal jika waktu tidak berlebihan
3. Jika waktu transportasi akan berlebihan, mengalihkan ke rumah sakit terdekat.

Untuk semua kasus ketika seorang pasien dengan order DNR ditemui, petugas RSUD dr. Loekmono Hadi harus merekomendasikan berikut pada laporan perawatan pra-rumah sakit mereka

UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Ambulance 3. Rawat inap 4. Instalasi perawatan intensif 5. Instalasi Bedah Sentral